

**SURAT EDARAN
NOMOR : 993/RSPHS/I-SE/DIR/VIII/2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENJAMINAN ESWL**

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pasal 46 ayat (4) dan berdasarkan Surat Pemberitahuan BPJS Kesehatan nomor 1821VII-06//0724 tentang Kebijakan Penjaminan ESWL menjelaskan bahwa Manfaat Jaminan Kesehatan yang menjadi hak dari Peserta salah satunya adalah manfaat medis yang terstandar yang efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut untuk memastikan penjaminan manfaat pelayanan tindakan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) yang efektif dan efisien, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1560/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Batu Saluran Kemih, yang saat ini menjadi standar pedoman nasional pelaksanaan pelayanan tindakan ESWL, di dalamnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Indikasi umum pengangkatan batu saluran kemih
 - b. Indikasi pemilihan ESWL untuk pengangkatan batu saluran kemih
 - c. Kontra indikasi ESWL
 - d. Faktor-faktor pendukung keberhasilan ESWL
 - e. Standar pemeriksaan pencitraan dan pemeriksaan
2. Ketentuan Penjaminan Manfaat pelayanan tindakan ESWL meliputi :
 - a. Tindakan dilakukan sesuai indikasi medis, termasuk ukuran batu, densitas batu, dan jarak antara batu dengan permukaan kulit pasien.
 - b. Mengikuti standar prosedur dan kewenangan klinis yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
 - c. Sesuai jumlah frekuensi maksimal tindakan ESWL berulang yang direkomendasikan. Rincian ketentuan penjaminan manfaat pelayanan tindakan ESWL sebagaimana terlampir
3. Selanjutnya untuk keseragaman penjaminan ESWL yang bermutu, efektif dan efisien, maka dimohon seluruh FKRTL dengan tindakan ESWL dapat mengikuti ketentuan pedoman penjaminan ESWL. Monitoring dan evaluasi termasuk utilization review terkait penjaminan tindakan ESWL di FKRTL akan dilakukan secara berkala.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijalankan. Kebijakan ini berlaku sejak Surat Edaran ini diterbitkan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 16 Agustus 2024
Direktur RS Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS



Lampiran

Surat Edaran Kebijakan ESWL

Nomor : 993/RSPHS/I-SE/DIR/VIII/2024

RANGKUMAN PANDUAN PENJAMINAN ESWL

1. Berdasarkan PNPB Batu Saluran Kemih tidak seluruh batu saluran kemih harus dilakukan pengangkatan secara aktif, beberapa kondisi dapat didahului dengan observasi dan atau terapi farmakologis.
2. Observasi dan/atau terapi farmakologis pada batu saluran kemih dilakukan pada kondisi:
 - Pada batu ginjal kaliks inferior **asimptomatik** ≤ 10 mm, dilakukan observasi tahunan. Bila ada penambahan ukuran batu, interval observasi perlu diperpendek.
 - Pada **batu ginjal dengan jenis batu asam urat** dapat diberikan tata laksana farmakologis.
 - Pada **batu ureter** dengan ukuran < 5 mm, jika **asimptomatik** dan tidak ada indikasi pengangkatan batu, maka dapat dilakukan **observasi** dengan evaluasi berkala. **Batu ureter dengan ukuran > 5 mm dan ≤ 10 mm** direkomendasikan untuk dilakukan terapi farmakologis/MET *MET (medical expulsion therapy)*.
3. Indikasi adanya pengangkatan batu ginjal secara aktif antara lain:
 - a. Pertambahan ukuran batu.
 - b. Pasien risiko tinggi terjadinya pembentukan batu.
 - c. Obstruksi yang disebabkan oleh batu.
 - d. Infeksi saluran kemih (Konfirmasi dengan pemeriksaan kultur urin).
 - e. Batu yang menimbulkan gejala seperti nyeri, kolik, dan dapat disertai dengan disuria, hematuria, frekuensi, retensi urin, nyeri suprapubik dan anuria.
 - f. Ukuran batu > 15 mm.
 - g. Ukuran batu < 15 mm jika observasi bukan merupakan pilihan terapi.
 - h. Komorbiditas
4. Indikasi pengangkatan batu ureter secara aktif antara lain:
 - a. Batu dengan kemungkinan rendah untuk keluar secara spontan.
 - b. Nyeri persisten setelah terapi analgesik adekuat.
 - c. Obstruksi persisten.
 - d. Insufisiensi ginjal (gagal ginjal, obstruksi bilateral, atau ginjal soliter).
 - e. Kelainan anatomi ureter.
 - f. Batu tidak keluar setelah 4 - 6 minggu MET.



5. Terdapat beberapa pilihan terapi pengangkatan batu saluran kemih antara lain adalah:
 - a. ESWL
 - b. PCNL (*Percutaneous Nephrolithotomy*)
 - c. URS (*ureterorenoskopi*)
 - d. Operasi pengangkatan terbuka serta laparoskopik.
6. Dalam hal peserta terindikasi untuk tindakan ESWL, maka agar dipastikan faktor pendukung dan kondisi sebagai berikut:
 - a. Batu ginjal ukuran 10-20 mm.
 - b. Batu ureter ukuran maksimal 20 mm dan dilakukan dengan guiding c-arm dan USG.
 - c. Dapat dimungkinkan dilakukan pada batu ginjal ukuran > 20 mm yang mempunyai kontraindikasi dilakukan tindakan endourologi, dengan didahului pemasangan DJ stent.
 - d. Batu dengan densitas maksimal 1.000 HU.
 - e. Jarak kulit dengan batu maksimal 10 cm.
 - f. Kewenangan pelaksanaan tindakan ESWL ada pada Dokter Spesialis Urologi
7. Kontraindikasi tindakan ESWL
 - a. Gangguan skeletal berat dan obesitas berat
 - b. Infeksi saluran kemih yang belum terkontrol
 - c. Kehamilan
 - d. Terdapat aneurisma pada daerah sekitar batu
 - e. Obstruksi distal secara anatomi yang dapat menghambat turunnya batu
 - f. Kelainan perdarahan, yang tidak dapat dikompensasikan dalam waktu setidaknya 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan 48 (empat puluh delapan) jam setelah tata laksana.
8. Pencitraan (*Imaging*)

Pemeriksaan CT Scan abdomen sangat direkomendasikan sebagai pemeriksaan penunjang yang optimal untuk meningkatkan angka keberhasilan tindakan ESWL. Hal ini dapat dikecualikan pada kondisi keterbatasan rujukan dan atau alat CT Scan di suatu daerah, khususnya pada daerah terpencil/akses terbatas.

Salah satu faktor utama yang berperan penting dalam keberhasilan tindakan ESWL dan mencegah kejadian ESWL berulang adalah ketepatan dalam menentukan jenis, ukuran, dimensi, densitas dan posisi batu saluran kemih, yang bisa didapatkan dengan menggunakan CT scan abdomen.

 - a. Standar Diagnostik ESWL
 - CT Scan Abdomen
 - Menentukan ukuran dan densitas batu
 - Memberikan gambaran dimensi batu yang adekuat



- Mendeteksi batu radiolusen dengan nilai sensitivitas dan spesifitas tinggi
- Mengukur jarak antara kulit dan batu, serta anatomi sekitarnya

b. Pencitraan Lainnya

➤ USG

- Berguna untuk mengidentifikasi batu pada kaliks, pelvis, sambungan pieloureter dan vesikoureter, dan buli-buli dengan nilai spesifitas yang baik.

➤ Foto polos abdomen atau sinar X *kidney-ureter-bladder* (KUB)

- Berguna untuk membedakan batu radioopak dan radiolusen serta kepentingan **follow-up pasca tindakan**.

➤ IVU

- Merupakan pemeriksaan alternatif apabila CT abdomen tidak memungkinkan.

➤ MRI

- Dipertimbangkan sebagai modalitas lini kedua untuk populasi yang rentan terhadap efek teratogenik dan karsinogenesis, misalnya wanita hamil dan anak.

9. Penjaminan Maksimal Tindakan ESWL Berulang:

- Jumlah ideal maksimal ESWL kurun waktu tertentu, yaitu **4 (empat) kali pada satu sisi (kanan atau kiri) dalam kurun waktu satu tahun, berlaku akumulasi untuk seluruh batu saluran kemih** (Rekomendasi PP IAU melalui Surat Nomor: 0053/STa.001/PP.IAU/II/2024).

- Penjaminan sesi tambahan ESWL dilakukan dengan memastikan terdapat perbaikan dalam hal pengurangan ukuran batu yang tersisa setelah tindakan awal/sebelumnya.

Tindakan ESWL yang telah memenuhi kriteria indikasi dan telah mengoptimalkan faktor pendukung, akan mendapatkan angka keberhasilan bebas batu (*stone free rate*) yang tinggi dalam satu kali tindakan ESWL.

- Sisa batu setelah tindakan ESWL dibuktikan melalui pemeriksaan pencitraan, yang optimal dilakukan dalam waktu 4 minggu setelah tindakan pertama (rekomendasi dari panduan *European Association of Urology*).
- Hasil pencitraan yang menunjukkan masih terdapat sisa batu ginjal dengan ukuran > 4 mm menunjukkan kemungkinan untuk dilakukan sesi ESWL tambahan, dengan pertimbangan bahwa batu ginjal ukuran maksimal 4 mm dapat keluar secara spontan (SFR = 80%).
- Jika tindakan ESWL telah mencapai 4 kali dalam setahun namun masih dibutuhkan tata laksana pengangkatan batu, maka untuk keberlangsungan tata laksana kasus batu saluran kemih terdapat pilihan tindakan pengangkatan batu lainnya, seperti PCNL (*Percutaneous Nephrolithotomy*), URS (*ureterorenoskopi*), dan atau



operasi pengangkatan terbuka/laparoskopik, sesuai dengan panduan dalam PNPk.

Penjelasan detail terkait tata laksana batu saluran kemih dapat dipelajari lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1560/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Batu Saluran Kemih.